

UNIVERSIDAD PERUANO CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DE ADHERENCIA EN PRÓTESIS DE DEDO

INGENIERÍA BIOMÉDICA PROYECTOS DE BIODISEÑO 1 Grupo 14

Docentes:

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Marco Antonio Mugaburu Celi
- Jhomer Rodrigo Contreras Pauca
- Jaime Luis Lam
- Félix Alonso Agapito Córdova

Integrantes:

- | | |
|----------------------------------|----|
| - Cieza Armas, Misael Andre | MC |
| - Bueno Nogueira, José David | JB |
| - De La Cruz Blas, Jorge Rodrigo | JD |
| - Ugarte Yupanqui, Diego Alberto | DU |
| - Alarcón Tirado, Mariano | MA |
| - Tinoco Quispe, Juan Antonio | JT |

Índice

1. Presentación y Contexto Clínico.....	3
2. Problemática.....	3
3. Estado del Arte.....	4
3.1. Artículos Académicos.....	4
3.2. Patentes.....	7
3.2.1. WO2023064323 - Prosthetic assembly having an electrode interface for recording muscle activity.....	7
3.2.2. US20100191153A1 – Prosthetic Limb Monitoring System.....	8
3.2.3. US10905570B2 – Prosthetic Partial Fingers.....	9
3.3. Revistas de Catálogos y Tecnologías Existentes/ Tecnologías existentes en el ámbito comercial.....	10
3.4. Páginas de Fabricantes.....	12
3.4.1. STMicroelectronics – Microcontroladores de Ultra Bajo Consumo STM32L.....	12
3.4.2. Bosch Sensortec – Sensor Inercial Inteligente BNO055.....	13
3.4.3. Texas Instruments – Transceptor Inalámbrico de Ultra Bajo Consumo CC2640R2F.....	14
4. Lista de exigencias.....	14
5. Estructura de funciones óptima.....	22
5.1 Black box.....	22
5.2 Secuencia de operaciones.....	23
5.3 Estructura de funciones.....	24
5. Referencias Bibliográficas.....	25

1. Presentación y Contexto Clínico

La rehabilitación integral de personas con amputación de miembro superior constituye un desafío biomédico complejo que involucra factores biomecánicos, fisiológicos y psicosociales [2], [3]. El éxito del proceso protésico no solo depende de la restitución cosmética o funcional pasiva, sino de la adopción continua del dispositivo en las actividades de la vida diaria [1], [4]. Investigaciones clínicas demuestran que un régimen de porte adecuado y prolongado mejora significativamente los desenlaces funcionales evaluados mediante escalas estandarizadas como PROMIS-9 UE [13] o cuestionarios estandarizados de movilidad y calidad de vida [3], [4], [14], al tiempo que reduce el dolor del miembro fantasma y previene el deterioro muscular por desuso [13].

Paralelamente, los individuos con amputación unilateral se ven obligados a realizar la mayoría de sus actividades cotidianas empleando la extremidad intacta restante [2]. Esta extremidad experimenta una notable sobrecarga mecánica, sobreuso y movimientos repetitivos [2], evidenciándose una prevalencia de molestias musculoesqueléticas del 65% en personas con amputación unilateral frente al 34% en personas sin ausencia de miembro superior [2]. Por ende, la preservación funcional del miembro remanente y la reinserción ocupacional del paciente exigen intervenciones que integren el soporte psicosocial [3] junto a tecnologías de apoyo y monitoreo continuo [1], [6], [13].

2. Problemática

A pesar de los avances en el diseño y manufactura de extremidades artificiales, la tasa de rechazo y abandono definitivo de prótesis de miembro superior oscila históricamente entre el 30% y el 50% [14], [15]. Estudios longitudinales en cohortes de pacientes evidencian que el abandono no ocurre porque el usuario deje de requerir el dispositivo o mejore espontáneamente [14], sino que está fuertemente predicho por la insatisfacción con el dispositivo y por una disminución progresiva en la frecuencia y duración de su uso [14].

Aunque el diseño y manufactura de extremidades artificiales han mejorado, entre el 30 y 50%[14],[15] de los usuarios las rechazan o las abandonan por completo. Investigaciones en pacientes con prótesis evidencian que no ocurre porque el usuario lo deje de requerir o mejore espontáneamente[14],sino que se debe por la insatisfacción con el dispositivo y en un uso cada vez menos frecuente[14].

En la práctica clínica habitual, la evaluación de la adherencia al tratamiento se realiza mediante encuestas retrospectivas y reportes verbales del paciente, métodos subjetivos propensos a sesgos de memoria y sobreestimación de horas de porte [14], [15]. La literatura científica establece como umbral estándar de buena

adherencia o uso exitoso un registro igual o superior a 8 horas diarias [4], [15], clasificando regímenes de 6.5 horas/día o menores como indicadores de pobre adherencia o riesgo inminente de abandono [15]. Actualmente, el equipo médico carece de herramientas cuantitativas, continuas y de bajo costo que permitan registrar objetivamente el tiempo real de uso y caracterizar la dinámica funcional de la prótesis en entornos cotidianos [1], [6], [14], impidiendo la detección temprana del rechazo y el ajuste oportuno de las terapias de rehabilitación [2], [3], [13].

3. Estado del Arte

3.1. Artículos Académicos

El monitoreo cuantitativo de la actividad física y el control biomecatrónico se sustenta en tres grandes categorías tecnológicas: sensores electromecánicos, bioeléctricos y biomecánicos [1]. En el ámbito cinemático, las Unidades de Medición Inercial (IMU) compuestas por acelerómetros y giroscopios permiten registrar la aceleración angular y la orientación espacial de las extremidades [1], [9], [11]. Para mitigar el ruido de alta frecuencia del acelerómetro y la deriva temporal (*drift*) del giroscopio, se han desarrollado e implementado filtros complementarios no lineales integrados a modelos cinemáticos del miembro superior [11], lo que hace posible reconstruir trayectorias tridimensionales de las extremidades y discriminar movimientos funcionales del brazo durante actividades de la vida diaria [11].



Figura 1. Dispositivos portátiles comerciales típicos para el monitoreo y seguimiento de la actividad. (a) Vicon; (b) Fitbit Flex; (c) XSens; (d) TracPatch; (e) Movesense; (f) APDM; (g) Noraxon; (h) BioX Bands.

En lo referente a la instrumentación de los actuadores y falanges, los sensores piezoeléctricos flexibles han demostrado una alta efectividad (>93%) en la detección y clasificación de patrones de movimiento y transiciones posturales sin interferir con la movilidad natural [16]. Asimismo, se han desarrollado sensores textiles de fuerza adaptables para dotar de retroalimentación táctil a prótesis de mano [12], registrando variaciones piezorresistivas para identificar contactos y deslizamientos mecánicos durante tareas de agarre [12].

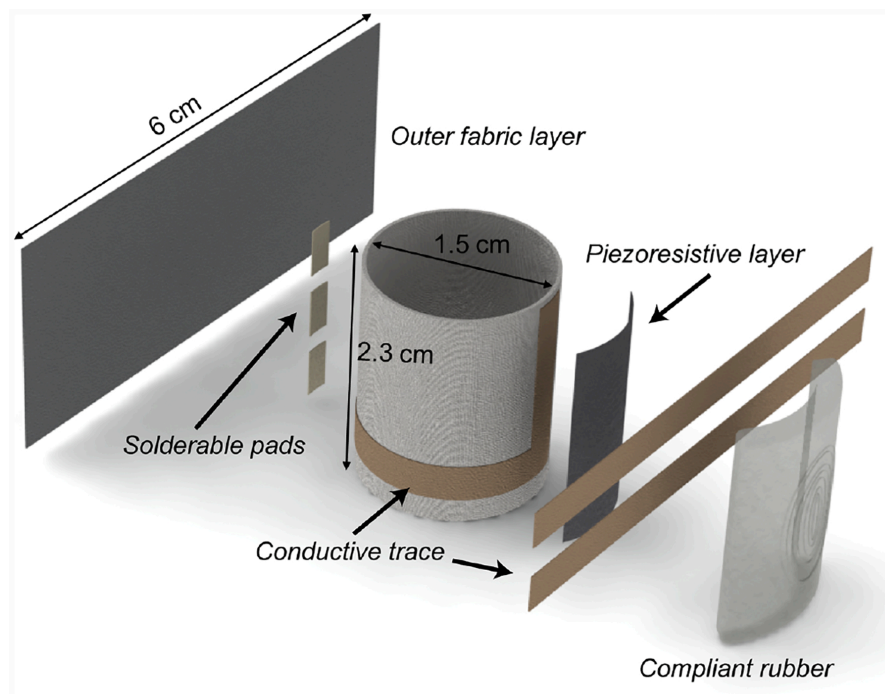


Figura 2. Diseño de sensor de brazalete para el dedo. Las pistas conductoras están fusionadas al brazalete textil interior. Posteriormente, se recubre con una capa exterior de tela y goma.

Por su parte, la recolección de energía ambiental y biomecánica mediante nanogeneradores triboeléctricos (TENG) y piezoeléctricos ha permitido la creación de sensores de flexión autoalimentados [5], [7], [10]. En estas configuraciones, el contacto y separación cíclica de materiales dieléctricos como PDMS y nailon inducen transferencias de carga que generan picos de voltaje proporcionales a la flexión del dedo [10], los cuales pueden integrarse con circuitos de acondicionamiento de impedancia adaptable para optimizar la señal de transducción y el aprovechamiento de potencia [5], [6].

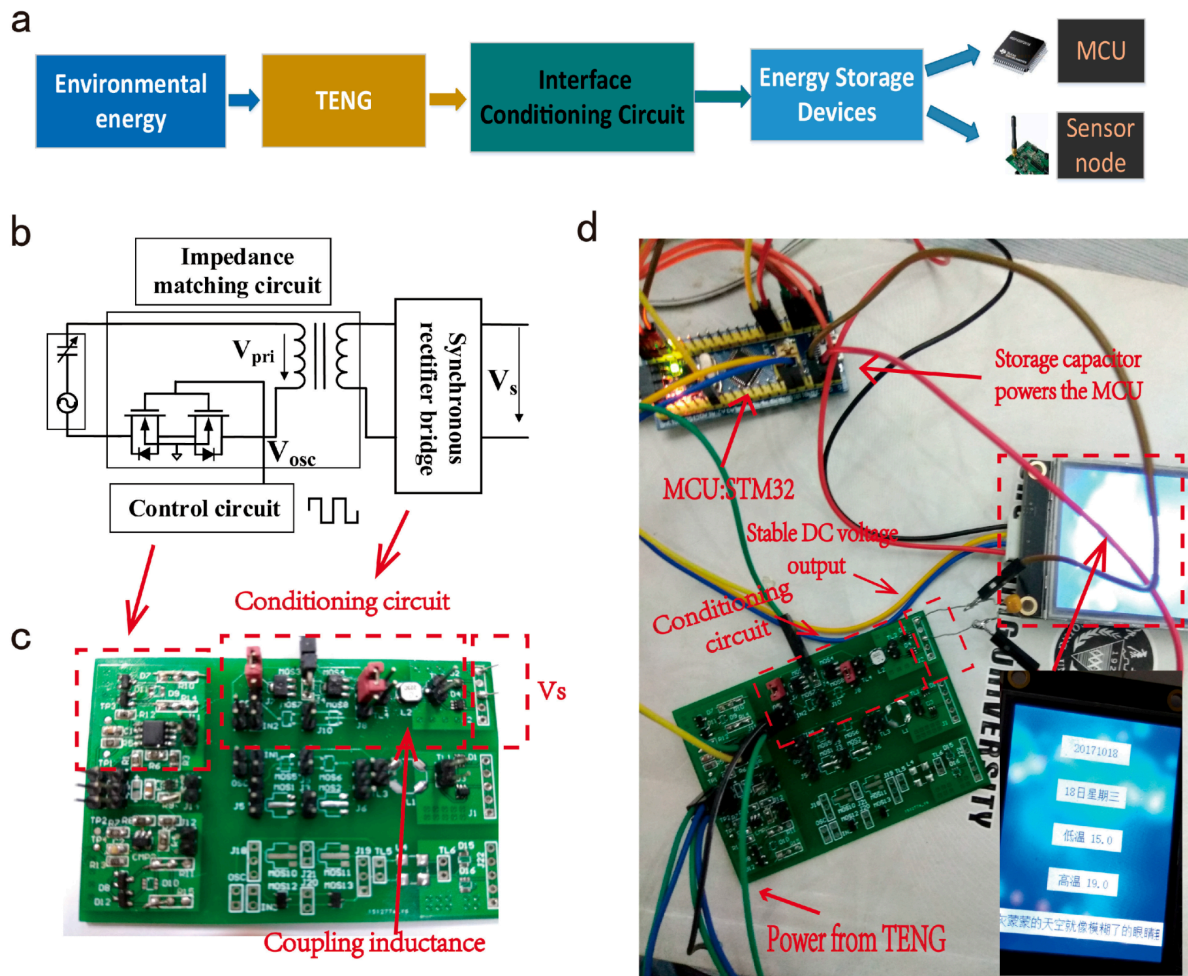


Figura 3. (**a**) Sistema de recolección de energía ambiental basado en TENG. (**b**) Circuito de acondicionamiento de interfaz para TENG. (**c**) Imagen física del circuito de acondicionamiento de interfaz. (**d**) Aplicación del sistema de recolección de energía ambiental basado en TENG y el circuito de acondicionamiento de interfaz.

3.2. Patentes

3.2.1. WO2023064323 - Prosthetic assembly having an electrode interface for recording muscle activity

En el ámbito de la propiedad intelectual enfocada en prótesis, la solicitud internacional **WO2023064323A1** describe un sistema de encaje protésico (*socket liner*) que integra electrodos directamente en su estructura para registrar señales de electromiografía de superficie (sEMG) en tiempo real [17]. Si bien este enfoque permite monitorizar la actividad muscular interna del muñón del paciente de forma directa [17], demanda esquemas de filtrado complejos frente a artefactos de movimiento del socket, alta susceptibilidad a la transpiración y un elevado costo por canal de adquisición frente a sistemas de naturaleza mecánica o cinemática externa [1], [17].

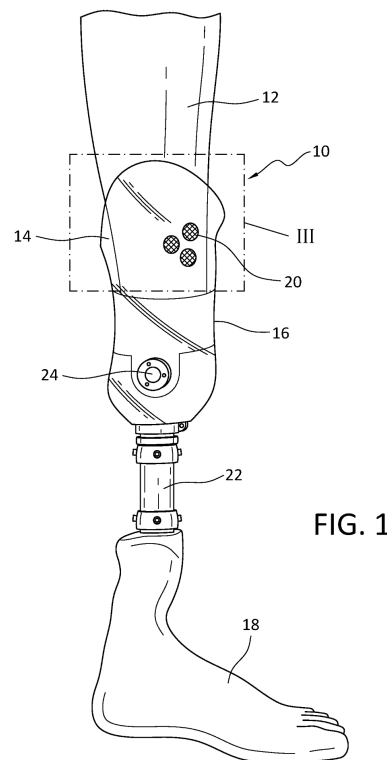


Figura 4. Sistema de encaje protésico.

3.2.2. US20100191153A1 – Prosthetic Limb Monitoring System

La patente US20100191153A1 protege una arquitectura de instrumentación embebida orientada a cuantificar objetivamente la adherencia y el uso clínico continuo en prótesis de extremidad [23]. El sistema incorpora transductores de fuerza y acelerómetros acoplados a una unidad de adquisición local que registra perfiles de carga, duración de uso y patrones mecánicos ambulatorios durante las actividades diarias del paciente [23]. Los datos son procesados mediante algoritmos embebidos para discriminar episodios de inactividad respecto a regímenes de porte activo, almacenando y transmitiendo telemáticamente la información hacia un servidor remoto para sustituir las evaluaciones basadas en encuestas subjetivas [23].

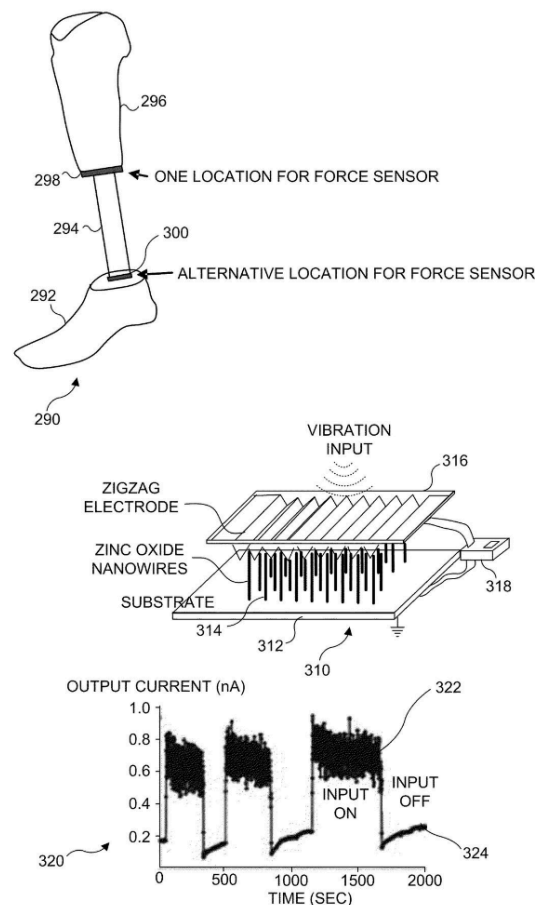


Figura 5. Locación y sensores de movimiento.

3.2.3. US10905570B2 – Prosthetic Partial Fingers

La patente US10905570B2 describe el diseño mecánico y cinemático de prótesis de dedos parciales articuladas, accionadas mediante la flexión del muñón residual y la tracción de tendones mecánicos dorsales [24]. La invención define la configuración geométrica de los eslabones rígidos, pivotes y correderas dorsales que garantizan un acoplamiento articular estable en un rango de 0° a 90° [24]. Este diseño delimita los puntos de anclaje anatómicos y recorridos cinemáticos aptos para la fijación de sensores de deformación o tirantes mecánicos sin limitar el rango biomecánico de la mano [24].

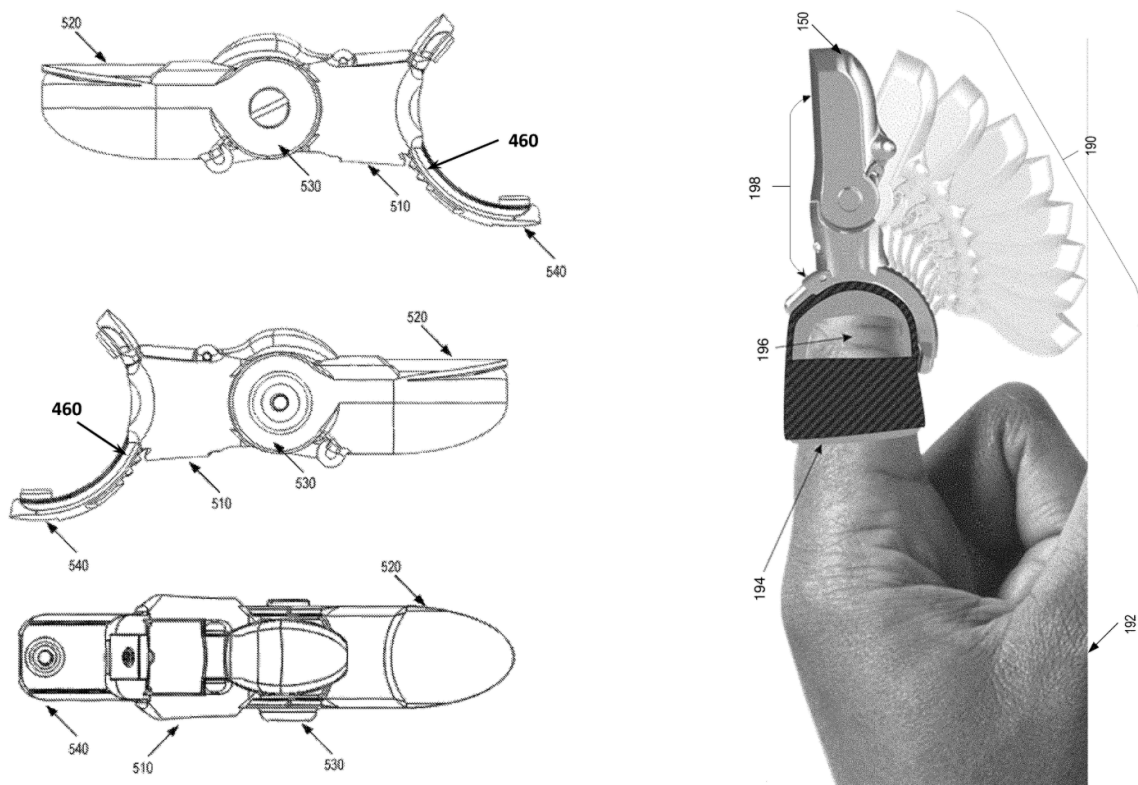


Figura 6. Diseño mecánico y cinético de la prótesis

3.3. Revistas de Catálogos y Tecnologías Existentes/ Tecnologías existentes en el ámbito comercial

En los catálogos especializados de componentes biomecatrónicos y plataformas de sensado, las interfaces mioeléctricas superficiales comerciales (módulos sEMG analógicos con filtrado integrado) alcanzan costos elevados, aproximados a los 370 PEN por canal transductor [1], [17]. Por otro lado, los catálogos de hardware embebido presentan matrices inerciales compactas de 6 a 9 grados de libertad (módulos IMU como la serie BNO055 o similares), que ofrecen bajo factor de forma y un costo accesible cercano a los 5 USD por unidad [9], permitiendo su interconexión mediante buses I2C o SPI a microcontroladores de arquitectura ARM como se muestra en la **Figura 5** [9]. Igualmente, las resistencias sensibles a la fuerza (FSR) y las películas piezorresistivas conforman opciones estándar y de bajo costo en catálogos para medir la distribución de presión en el socket o las zonas de contacto palmar [1], [6], [12].



Figura 7. "Inertial Measurement Units sensors"

En el catálogo de componentes de instrumentación de SparkFun Electronics se documenta el transductor inercial MPU-6050 (módulo Breakout SEN-11028), el cual integra en un encapsulado compacto de 25.4 x 15.2 mm un acelerómetro triaxial piezorresistivo y un giroscopio MEMS de tres ejes [25]. La plataforma detalla su compatibilidad nativa con buses I2C a tensiones lógicas de 3.3 V y 5 V, así como la inclusión de un procesador digital de movimiento (*Digital Motion Processor*, DMP) interno capaz de calcular derivas cinemáticas y vectores de orientación angular en tiempo real, constituyendo una alternativa comercial viable (~5 a 8 USD) para la monitorización de articulaciones distales [25].

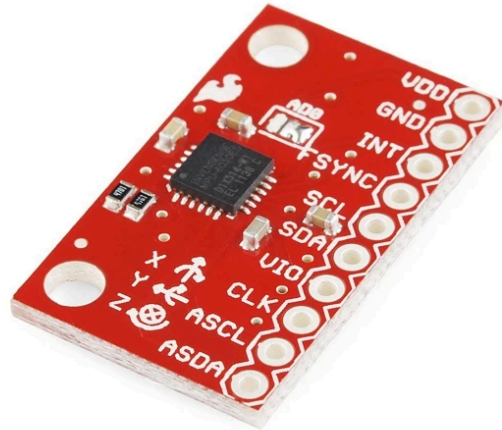


Figura 8. SparkFun Triple Axis Accelerometer and Gyro Breakout - MPU-6050

Por su parte, el catálogo de sensores biomecánicos y táctiles de Interlink Electronics documenta la serie comercial FSR 400, específicamente el modelo circular FSR 402, diseñado para registrar fuerza dinámica y estática perpendicular en un intervalo de 0.2 N a 20 N [26]. El catálogo describe un espesor ultrafino menor a 0.5 mm y un diámetro activo de 12.7 mm con sustrato de poliamida flexible, presentando una disminución logarítmica de su resistencia eléctrica en respuesta a la carga aplicada [26]. Esta especificación técnica respalda su uso comercial directo en zonas de contacto del muñón o encajes para verificar el porte continuo de la prótesis con mínimo impacto volumétrico [26].



Figura 9. FSR 402

3.4. Páginas de Fabricantes

3.4.1. STMicroelectronics – Microcontroladores de Ultra Bajo Consumo STM32L

La documentación técnica oficial de STMicroelectronics (Nota de Aplicación AN4621 y hoja de datos de la serie STM32L0/L4) detalla las técnicas de gestión energética en microcontroladores embebidos de 32 bits basados en el núcleo ARM Cortex-M0+/M4 [27]. El fabricante especifica modos de bajo consumo avanzados (*Stop Mode* y *Standby Mode*) que reducen la demanda de corriente por debajo de $1\mu\text{A}$ manteniendo la retención en memoria SRAM [27]. Asimismo, documenta el uso de periféricos autónomos de bajo consumo (*Low-Power UART* y líneas de interrupción externa EXTI) capaces de despertar al procesador a partir de flancos de tensión ascendentes inducidos por transductores autoalimentados o eventos inerciales, posibilitando una operación prolongada en dispositivos portables de telemedicina [27].

3.4.2. Bosch Sensortec – Sensor Inercial Inteligente BNO055

La hoja de especificaciones de ingeniería de Bosch Sensortec para el sensor BNO055 describe un sistema en encapsulado (SiP) que integra un acelerómetro de 14 bits, un giroscopio de 16 bits y un magnetómetro geomagnético, junto con un microcontrolador Cortex-M0 de 32 bits dedicado a ejecutar algoritmos de fusión sensorial *BSX3.0 FusionLib* [28]. El fabricante detalla que el chip entrega directamente cuaterniones, ángulos de Euler y vectores de aceleración lineal compensados por gravedad sin recargar el procesamiento de la unidad central, operando a 3.3V con un consumo en modo activo de 12.3mA y modos de reposo programables configurables mediante interrupciones de movimiento angular [28].



Figura 10. sensor BNO055

3.4.3. Texas Instruments – Transceptor Inalámbrico de Ultra Bajo Consumo CC2640R2F

El fabricante Texas Instruments presenta en la especificación técnica del circuito integrado CC2640R2F un microcontrolador inalámbrico optimizado para aplicaciones Bluetooth Low Energy 4.2 y 5.0 en tecnología médica portable [29]. La documentación destaca una arquitectura de radiofrecuencia de muy bajo consumo que consume únicamente 6.1 mA en recepción (RX) y 9.1 mA en transmisión (TX a +5 dBm), complementada por un controlador de sensores propietario (*Sensor Controller Engine*) independiente de 16 bits [29]. Esta arquitectura permite interrogar periódicamente entradas analógicas y transductores piezoeléctricos/triboelectrónicos consumiendo únicamente 8.2µA/MHz, reservando el encendido del radio principal exclusivamente para la transmisión de paquetes telemétricos de adherencia a la nube [29].

4. Lista de exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág: 4
			Edición: Rev 1
Proyecto:	“SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DE ADHERENCIA EN PRÓTESIS DE DEDO”	Fecha: 04/09/2026	
		Revisado:	
Cliente: profesores colocar	UNIVERSIDAD PERUANO CAYETANO HEREDIA	Elaborado:	
Fecha (cambios)	Deseo exigencia	Descripción	Responsable
12/09/2026	E	Función principal: - Registrar de forma no invasiva si una prótesis de miembro superior está en uso funcional real, diferenciando el uso activo del desplazamiento pasivo y transmitir esta información a una plataforma remota para consulta del especialista clínico.	J.T, D.U, M.A, M.C, J.B, J.D

12/09/2026	E	Función secundaria: - Registrar y almacenar los datos de uso de la prótesis, procesarlos y analizarlos mediante técnicas de machine learning para identificar patrones de uso y generar información relevante para el usuario y/o especialista.	J.T, D.U, M.A, M.C, J.B, J.D
12/09/2026	E E E	Geometría: - Dimensiones mínimas: 45.0 X 30.0 X 10.0 mm, fundamentadas en el factor de forma compacto de dispositivos clínicos y comerciales como Movesense, Fitbit Flex y XSens. - Dimensiones máximas: 65.0 X 45.0 X 18.0 mm, establecidas como límite biomecánico dorsal en el antebrazo para no interferir con la flexo-extensión ni desbalancear la prótesis. - Limitar el ancho del sensor de flexión de acuerdo con el espacio disponible en la superficie dorsal del segmento medio del Knick Finger, considerando las dimensiones parametrizables de la prótesis. [23].	J.B, J.D
12/09/2026	E	Cinemática: - Detectar la flexión funcional de la articulación interfalángica proximal (PIP) dentro de un rango de 23° a 87° [21], aplicando una banda de histéresis de $\pm 1^\circ$ en ambos límites (22°-24° y 86°-88°) para evitar cambios de estado producidos por pequeñas fluctuaciones de la medición.	M.A, J.B
12/09/2026	E	Fuerzas: - En base del estado del arte, usar una masa mínima de 85 g, incluyendo	M.A, J.B

		encapsulado, sistema de procesamiento, sensores y sistema de almacenamiento de energía, para prevenir la sobrecarga mecánica y la fatiga en el muñón.	
12/09/2026	E E E E	Energía: - Alimentar el sistema mediante un sistema de almacenamiento de energía recargable integrado al wearable, suministrando energía a los sensores y al sistema de procesamiento de información. - Garantizar una autonomía mínima de 12 horas de funcionamiento continuo, permitiendo realizar el monitoreo durante una jornada prolongada sin necesidad de recarga. - Mantener un bajo consumo energético del sistema para prolongar la autonomía del almacenamiento de energía. - Permitir la recarga del sistema de almacenamiento de energía para su reutilización durante el monitoreo cotidiano.	J.T, M.C, D.U
16/09/2026	E E E E E	Señales: Señales de entrada - Recibir una señal de reloj para contabilizar la duración de los estados de uso activo, uso pasivo y sin uso de la prótesis. - Recibir una señal de contacto para determinar de forma continua si el wearable se encuentra colocado o no en el usuario. - Recibir una señal de movimiento de la prótesis, asociada a la flexión y/o cambio de posición del dedo, para identificar actividad funcional mientras el wearable se encuentra colocado. - Recibir una señal de encendido/apagado para determinar el estado operativo del sistema. Señales de salida - Generar el tiempo de movimiento funcional de la prótesis, correspondiente	J.T, M.C, D.U

	E	a los periodos de uso activo.	
	E	- Generar el tiempo de adherencia, correspondiente al tiempo total durante el cual el wearable permanece colocado en el usuario.	
	E	- Generar estadísticas de uso pasivo, correspondientes a los periodos en los que el wearable permanece colocado sin registrar movimiento funcional.	
	E	- Generar el tiempo sin uso, correspondiente a los periodos en los que el wearable no se encuentra colocado.	
	E	- Generar una señal visual para indicar el estado de encendido/apagado del sistema.	
12/09/2026	E	Control:	J.T, M.C, D.U
	E	- Clasificar automáticamente los intervalos de tiempo en tres categorías de uso: activo (prótesis colocada con movimiento funcional voluntario), pasivo (prótesis colocada sin movimiento funcional voluntario) y sin uso (prótesis no colocada).	
	E	- Registrar el tiempo de uso de la prótesis con un error no mayor al 5% respecto al tiempo de uso real [22].	
	D	- Verificar el contraste del registro con una grabación de referencia del paciente durante sesiones de prueba. [22]	
18/09/2026	E	Electrónico (hardware):	J.T, M.C, D.U
	E	- Procesar las señales captadas en las distintas ubicaciones de sensado (encaje, muñeca y articulación del dedo), mediante secciones electrónicas interconectadas entre sí.	
18/09/2026	E	Software:	M.C, M.A
	E	- Convertir las señales captadas en una medida estimada de horas de uso efectivo de la prótesis.	
	D	- Aplicar técnicas de machine learning para el reconocimiento de patrones de uso a partir de las señales registradas.	

12/09/2026	E E	Comunicaciones: - Transmitir periódicamente los datos procesados hacia una aplicación, manteniendo un consumo energético bajo en la conexión. - Registrar el autorreporte del usuario como información complementaria al registro automático.	J.T, M.C, D.U
18/09/2026	E E D D	Seguridad: - Evitar todo riesgo para la piel o el bienestar del usuario mediante un diseño no invasivo. Garantizar la privacidad de la información de salud transmitida. - Contar con un grado de protección mínimo IP54, según la norma IEC 60529, que soporte polvo limitado y salpicaduras de agua desde cualquier dirección [20][36]. - Contar que no cubra chorros de agua directos ni inmersión: el usuario debe retirar el dispositivo antes de lavarse las manos, ducharse o exponerlo a inmersión completa. - Priorizar usar materiales certificados conforme a las normas ISO 10993-10 (sensibilización cutánea) e ISO 10993-23 (irritación) en las superficies de contacto directo y prolongado con la piel del paciente [34][35].	D.U, J.B
04/09/2026	E E	Ergonomía: - Evitar interferir con el uso normal de la prótesis o con la comodidad del usuario. - Evitar que la prótesis lastime o dañe el dedo paciente.	J.D, J.B
18/09/2026	E	Fabricación: - Utilizar una carcasa rígida en PETG por su resistencia mecánica y baja higroscopicidad ante el sudor, combinada con acoples/sellos en TPU para amortiguación de impactos y adaptabilidad conformable a la	J.T, D.U, M.A, M.C, J.B, J.D

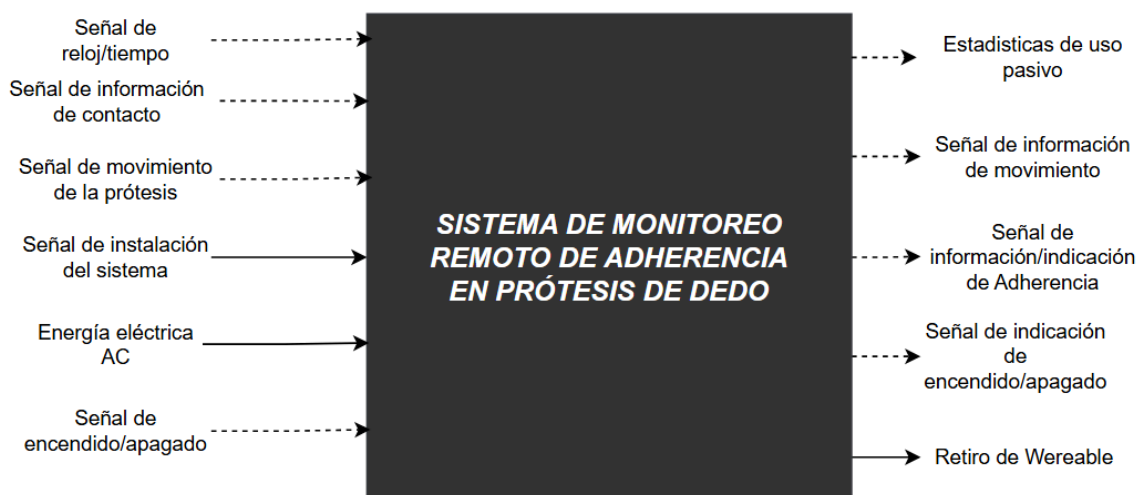
	E E	geometría protésica, materiales ya empleados en prótesis de dedo y mano impresas en 3D evaluadas con pacientes [32][33]. - Resistir las vibraciones propias del uso diario sin alterar su funcionamiento ni su calibración. - Permitir el reemplazo de la pieza física, incluyendo impresión y ensamblaje, en un tiempo preliminar no mayor a 3 horas [18] (validar mediante prueba cronometrada una vez construido el prototipo).	
18/09/2026	D D D	Control de calidad: - Validar el error del registro del tiempo de uso mediante contraste con una grabación de referencia del paciente. - Verificar mediante prueba cronometrada que el tiempo de reemplazo de la pieza física no exceda las 3 horas. - El dispositivo deberá ser sometido a pruebas funcionales en condiciones de uso de zonas rurales del Perú (temperatura, humedad, polvo).	J.T, D.U, M.A, M.C, J.B, J.D
18/09/2026	E E	Montaje: - Permitir el montaje modular en secciones independientes según la ubicación de cada sensor (encaje, muñeca y articulación del dedo), con acceso al compartimento de batería para su recarga sin herramientas externas. - Permitir que cada sección sea instalada y desmontada sin herramientas externas en un plazo no mayor de cinco minutos.	J.B, J.T
18/09/2026	E	Transporte/Portátil: - Ser portátil, permitiendo su traslado y uso junto con la prótesis sin necesidad de equipos.	J.D, J.B
18/09/2026		Uso:	J.T, D.U

	E	- Permitir el monitoreo durante actividades cotidianas sin contacto directo con agua (como comer, escribir o manipular objetos), sin requerir intervención constante del usuario para registrar los datos.	
	E	- Requerir que el usuario retire el dispositivo antes de bañarse, lavarse las manos o exponerlo a inmersión en agua, en concordancia con el grado de protección IP54.	
18/09/2026	E	Mantenimiento: - Requerir mantenimiento e inspección periódica del wearable con una frecuencia preliminar de dos a tres veces por semana, dado que en los puntos de contacto directo y prolongado con la piel, el material de la carcasa genera un efecto oclusivo que atrapa el sudor entre el dispositivo y la piel, exponiendo esa zona a maceración cutánea [19]; esto se debe tanto al recambio natural de la epidermis, que ocurre cada 7-10 días (más rápido en zonas ocluidas) [30], como a las recomendaciones de higiene para componentes en contacto con la piel en usuarios de prótesis de miembro superior, que sugieren una limpieza a esta frecuencia [31].	J.B, D.U
12/09/2026	E	Costos: - El costo de materiales y componentes electrónicos del prototipo no debe exceder el rango de S/300. - El costo de mano de obra se considera un aproximado de 12 horas totales del equipo por semana. (S/45 por hora aprox). En total el monto es de S/51 840.	J.T, D.U, M.A, M.C, J.B, J.D
12/09/2026	E	Plazos: - Completar el desarrollo del prototipo (diseño, fabricación, ensamblaje y pruebas) antes del 5 de diciembre de 2026, según el cronograma del curso.	J.T

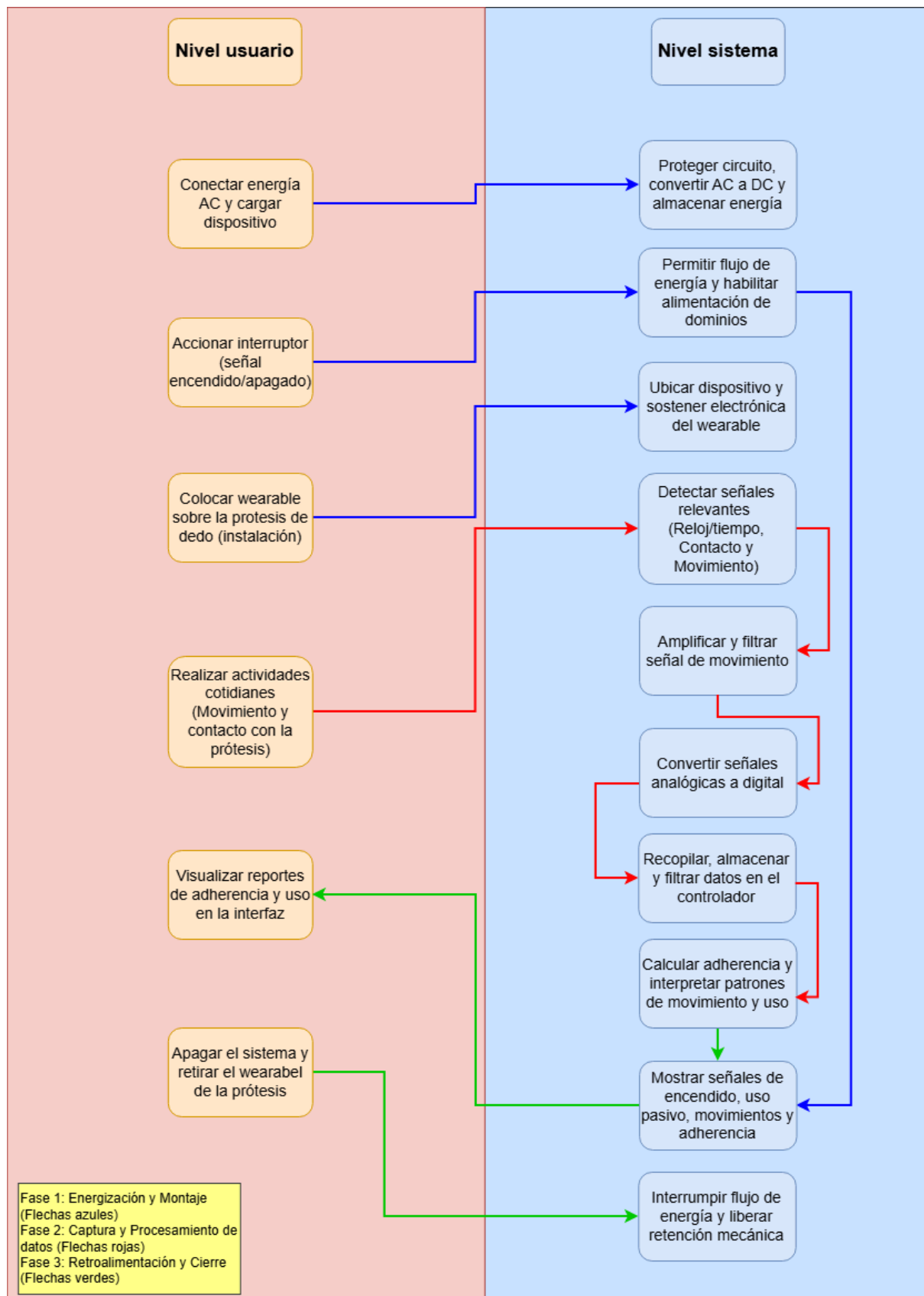
		- Diseño y matriz morfológica: 2 semanas - Materiales/componentes: ½ semanas - Fabricación e impresión 3D: 1 semana - Ensamblaje electrónico: 2 semanas - Pruebas y calibración: 2 semanas	
--	--	--	--

5. Estructura de funciones óptima

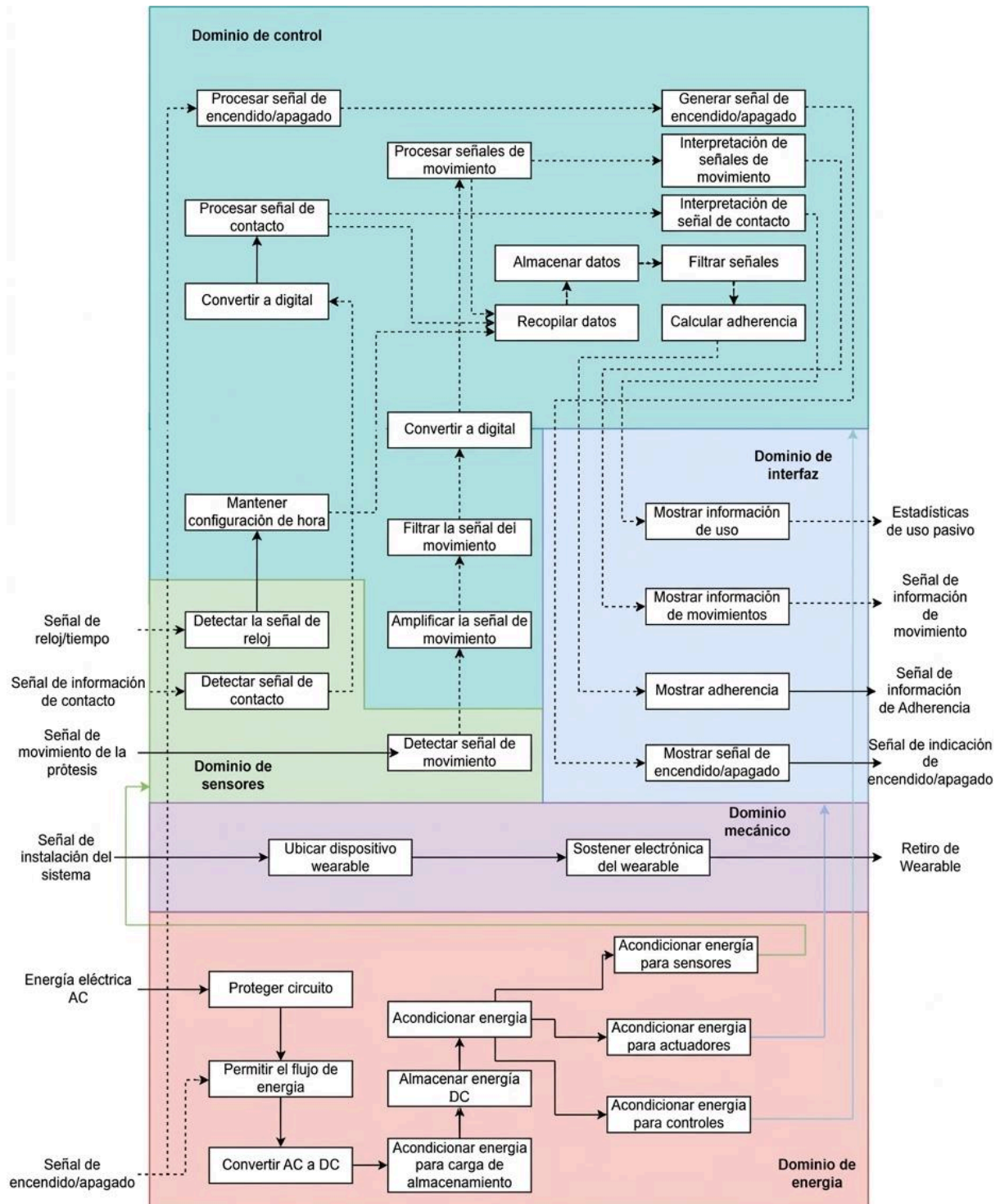
5.1 Black Box



5.2 Secuencia de operaciones



5.3 Estructura de funciones



6. Referencias Bibliográficas

- [1] X. Wang, H. Yu, S. Kold, O. Rahbek, y S. Bai, «Wearable sensors for activity monitoring and motion control: A review», *Biomim. Intell. Robot.*, vol. 3, n.o 1, p. 100089, mar. 2023, doi: 10.1016/j.birob.2023.100089.
- [2] S. R. Flinn y G. Goodman, «Effective assessments to identify overuse injuries in unaffected limbs of persons with unilateral upper limb amputations», *J. Hand Ther.*, vol. 34, n.o 2, pp. 298–308, abr. 2021, doi: 10.1016/j.jht.2021.05.006.
- [3] Milandeep *et al.*, «Impact of Psychosocial intervention on Quality of life in patients with post-traumatic limb amputation/s: a randomized controlled trial: Psychosocial care in post-traumatic amputees», *Injury*, vol. 57, n.o 3, p. 113027, mar. 2026, doi: 10.1016/j.injury.2026.113027.
- [4] K. Harb *et al.*, «Functional and quality-of-life outcomes of osseointegration vs socket prostheses in transfemoral amputees: A narrative review», *J. Orthop. Rep.*, vol. 5, n.o 4, p. 101046, ago. 2026, doi: 10.1016/j.jorep.2026.101046.
- [5] Y. Hu *et al.*, «An Adaptable Interface Conditioning Circuit Based on Triboelectric Nanogenerators for Self-Powered Sensors», *Micromachines*, vol. 9, n.o 3, p. 105, mar. 2018, doi: 10.3390/mi9030105.
- [6] K.-B. Chang *et al.*, «A triboelectric nanogenerator-based tactile sensor array system for monitoring pressure distribution inside prosthetic limb», *Nano Energy*, vol. 111, p. 108397, jun. 2023, doi: 10.1016/j.nanoen.2023.108397.
- [7] D. Babu, A. Nasir, M. Farag, M. H. M. Sidik, y S. B. M. Rejab, «Development of Prosthetic Robotic Arm with Patient Monitoring System For Disabled Children; Preliminary Results», en *2022 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE)*, mar. 2022, pp. 206–212, doi: 10.1109/ICEEE55327.2022.9772565.
- [8] N. N. A. H. Zahri *et al.*, «Wearable strain sensors: design shapes, fabrication, encapsulation and performance evaluation methods», *Sens. Diagn.*, vol. 3, n.o 10, pp. 1635–1650, oct. 2024, doi: 10.1039/d4sd00190g.
- [9] D. D. Khoa, N. N. Vinh, y N. M. Hieu, «Development of Data Gloves for Humanoid Robot Hand Simulation and Hand Posture Recognition», en *Advances in Asian Mechanism and Machine Science*, N. V. Khang, N. Q.

Hoang, y M. Ceccarelli, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 292–301, doi: 10.1007/978-3-030-91892-7_27.

[10] P. Maharjan, T. Bhatta, H. Cho, y J. Y. Park, «A Highly Sensitive Self-Powered Flex Sensor for Prosthetic Arm and Interpreting Gesticulation», en *2020 IEEE 33rd International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)*, ene. 2020, pp. 665–668, doi: 10.1109/MEMS46641.2020.9056118.

[11] C. Chien, J. Xia, O. Santana, Y. Wang, y G. J. Pottie, «Non-linear complementary filter based upper limb motion tracking using wearable sensors», en *2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing*, may 2013, pp. 963–967, doi: 10.1109/ICASSP.2013.6637792.

[12] L. Osborn, W. W. Lee, R. Kaliki, y N. Thakor, «Tactile feedback in upper limb prosthetic devices using flexible textile force sensors», en *5th IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics*, ago. 2014, pp. 114–119, doi: 10.1109/BIOROB.2014.6913762.

[13] T. J. Castleberry *et al.*, «PROMIS-9 UE physical function demonstrates moderate responsiveness for patients following upper limb prosthesis intervention», *J. Patient Rep. Outcomes*, vol. 9, n.o 1, p. 17, feb. 2025, doi: 10.1186/s41687-025-00843-y.

[14] L. Resnik, M. Borgia, S. Biester, y M. A. Clark, «Longitudinal study of prosthesis use in veterans with upper limb amputation», *Prosthet. Orthot. Int.*, vol. 45, n.o 1, pp. 26–35, feb. 2021, doi: 10.1177/0309364620957920.

[15] W. J. Gaine, C. Smart, y M. Bransby-Zachary, «Upper Limb Traumatic Amputees: Review of prosthetic use», *J. Hand Surg.*, vol. 22, n.o 1, pp. 73–76, feb. 1997, doi: 10.1016/S0266-7681(97)80023-X.

[16] Y. Cha, H. Kim, y D. Kim, «Flexible Piezoelectric Sensor-Based Gait Recognition», *Sensors*, vol. 18, n.o 2, p. 468, feb. 2018, doi: 10.3390/s18020468.

[17] A. O. Sverrisson y J. S. Bache Sigurdardottir, «Prosthetic Assembly Having an Electrode Interface for Recording Muscle Activity», 20 de abril de

2023 Accedido: 4 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en:
<https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2023064323>

[18] K. J. Young, J. E. Pierce, y J. M. Zuniga, «Assessment of body-powered 3D printed partial finger prostheses: a case study», *3D Print. Med.*, vol. 5, n.o 1, p. 8, may. 2019, doi: 10.1186/s41205-019-0044-0.

[19] F. Whitehead, S. Giampieri, T. Graham, y P. Grocott, «Identifying, managing and preventing skin maceration: a rapid review of the clinical evidence», *Journal of Wound Care*, vol. 26, n.o 4, pp. 159-166, abr. 2017, doi: 10.12968/jowc.2017.26.4.159.

[20] DG King Power Co., Ltd., «Understanding IP54 Protection Ratings Explained», dgkingpo.com. [En línea]. Disponible en:
<https://www.dgkingpo.com/understanding-ip54-protection-ratings-explained/>.

[21] G. I. Bain, N. Polites, B. G. Higgs, R. J. Heptinstall, y A. M. McGrath, «The functional range of motion of the finger joints», *J. Hand Surg. Eur. Vol.*, vol. 40, n.o 4, pp. 406–411, may. 2015, doi: 10.1177/1753193414533754.

[22] E. M. Bochniewicz, G. Emmer, A. W. Dromerick, J. Barth, y P. S. Lum, «Measurement of Functional Use in Upper Extremity Prosthetic Devices Using Wearable Sensors and Machine Learning», *Sensors*, vol. 23, n.o 6, p. 3111, mar. 2023, doi: 10.3390/s23063111.

[23] J. M. Czerniecki, G. E. Loeb, y H. Chizeck, «Prosthetic Limb Monitoring System», Patente US20100191153A1, 29 de julio de 2010. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20100191153A1/en>

[24] C. R. Choi y L. L. Macomber, «Prosthetic Partial Fingers», Patente US10905570B2, 2 de febrero de 2021. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US10905570B2/en>

[25] SparkFun Electronics, «SparkFun Triple Axis Accelerometer and Gyro Breakout - MPU-6050 (SEN-11028)», sparkfun.com, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.sparkfun.com/products/11028>

[26] Interlink Electronics, «FSR 400 Series Round Force Sensing Resistor - Datasheet», interlinkelectronics.com, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.interlinkelectronics.com/fsr-402>

[27] STMicroelectronics, «AN4621 Application note: STM32L4 and STM32L4+ power consumption modes and supply overview», st.com, Rev. 3, 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.st.com/resource/en/application_note/an4621-stm32l4-and-stm32l4-ultralowpower-features-overview-stmicroelectronics.pdf

[28] Bosch Sensortec GmbH, «BNO055 Intelligent 9-axis absolute orientation sensor - Datasheet», bosch-sensortec.com, Document BST-BNO055-DS000-18, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.bosch-sensortec.com/en/products/smart-sensor-systems/bno055>

[29] Texas Instruments, «CC2640R2F SimpleLink™ Bluetooth® low energy Wireless MCU - Datasheet», ti.com, SWRS204C, 2019. [En línea]. Disponible en: <https://www.ti.com/product/CC2640R2F>

[30] K. Godbey, «Wearable Sensors from the "Skin-Side" Out», 3M Medical Materials and Technologies, Technical Paper, jul. 2016. [En línea]. Disponible en: <https://multimedia.3m.com/mws/media/1478882O/wearable-sensors-from-the-skin-side-out-white-paper-final-pdf.pdf>

[31] Össur, «Caring for your limb, liner & prosthesis», ossur.com, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.ossur.com/en-za/prosthetics/information/limb-liner-prosthesis-care>

[32] D. F. Bustamante Bustamante, "Estudio paramétrico e impresión 3D de una prótesis de mano para niños," Tesis de pregrado, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, 2022.

[33] K. K. Kemala, "Evaluasi Kualitas Biomaterial dalam Prostetik Jari: Studi Kasus Penggunaan Material PLA, PETG dan TPU," Tesis de pregrado, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 2024.

[34] International Organization for Standardization, *Biological evaluation of medical devices — Part 10: Tests for skin sensitization*, ISO 10993-10:2021, Geneva, Switzerland, 2021.

[35] International Organization for Standardization, *Biological evaluation of medical devices — Part 23: Tests for irritation*, ISO 10993-23:2021, Geneva, Switzerland, 2021.

[36] International Electrotechnical Commission, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*, IEC 60529:1989, Ginebra, Suiza, 1989.